FIKTIVNÍ PACIENTKA – testovací data pro Rakathon 2026

Zápis k jednání multidisciplinárního týmu (MDT)

1 Základní údaje

Datum MDT:	21. 10. 2026
Pacient:	Alena Procházková, RČ 635722/1013
Pojišťovna:	211
Telefon, e-mail:	+420 777 000 541 · e-mail NEUVEDENO
Adresa:	Za Školou 17, 252 41 Dolní Břežany
Váha, výška:	65 kg (15. 9. 2026), 165 cm
Referující lékař:	MUDr. Tomáš Řezníček, praktický lékař
Telefon, e-mail:	+420 311 000 287 · e-mail NEUVEDENO
Případ prezentoval:	MUDr. Martin Svoboda, Interní gastroenterologická klinika

2 Členové MDT

- doc. MUDr. Pavel Hrubý, Ph.D. – chirurg, HPB chirurgie (předsedající)
- MUDr. Lenka Marková – klinická onkologie
- MUDr. Ondřej Kalous – radiační onkologie
- MUDr. Martin Svoboda – gastroenterologie
- MUDr. Eva Šimková – radiologie
- MUDr. Radek Pokorný, Ph.D. – patologie
- Bc. Lucie Dvořáková – koordinátorka KOC

3 Diagnóza

Název diagnózy:	Duktální adenokarcinom hlavy pankreatu, G2–G3, s perineurální invazí; hraničně resekabilní, cM0
Kód diagnózy (MKN-10):	C25.0

4 Komorbidity

Paroxysmální fibrilace síní na apixabanu, arteriální hypertenze, hypercholesterolémie; kardiologicky v červenci 2026 stabilní, EF LK 60 %. Výkonnostní stav (ECOG) v podkladech NEUVEDEN.

5 Výsledky stávajících vyšetření

Datum	Vyšetření	Výsledek
29. 9. 2026	UZ břicha	Hypoechogenní ložisko hlavy pankreatu 34 × 30 mm; mírná dilatace žlučových cest, bez jaterních ložisek.
8. 10. 2026	CT hrudníku a břicha, pankreatický protokol (KOC Nemocnice Severní)	Tumor hlavy pankreatu 35 × 31 mm, kontakt s VMS asi 200° se zúžením lumen v délce 18 mm, kontakt s AMS do 150° bez stenózy; suspektní peripankreatická uzlina 12 × 9 mm, bez vzdálených metastáz.
12. 10. 2026	EUS-FNB	Ložisko hlavy pankreatu 33 × 29 mm, provedena biopsie, bez komplikací.
15. 10. 2026	Laboratoř	Bilirubin 23 µmol/l, ALT 1,62, GGT 5,00, ALP 3,40 µkat/l, CA 19-9 312 kU/l, albumin 36 g/l, Hb 118 g/l, CRP 18 mg/l, kreatinin 74 µmol/l.
19. 10. 2026	Histologie	Duktální adenokarcinom pankreatu G2–G3, perineurální invaze; CK7+, CK19+, CK20−, CDX2−.

6 Závěr MDT

Histologicky potvrzený duktální adenokarcinom hlavy pankreatu G2–G3; kontakt s VMS asi 200° se zúžením lumen a s AMS do 150°, suspektní regionální uzlina, bez vzdálených metastáz. Hraničně resekabilní nález → neoadjuvantní systémová chemoterapie, poté restaging a znovuposouzení resekce v MDT.

7 Doporučení MDT

1. Neoadjuvantní chemoterapie: onkologické konzilium 4. 11. 2026 10:30, MUDr. Kalous.
2. Před zahájením léčby: stanovit ECOG, doplnit KO, jaterní a renální parametry, ionty a CA 19-9; zhodnotit cholestázu a potřebu zajištění průchodnosti žlučových cest (GE, případně ERCP). Biliární drenáž není doložena.
3. Po neoadjuvanci: kontrolní CT hrudníku a břicha (pankreatický protokol), CA 19-9 a nové MDT k resekabilitě (pankreatoduodenektomie s možností cévní rekonstrukce).
4. Nutriční intervence, zhodnocení bolesti a úprava analgezie, psychoonkologická podpora.
5. Kardiologická a medikační koordinace: postup s apixabanem před výkony individuálně s provádějícím lékařem; léčbu samostatně nevysazovat.
6. Koordinátorka KOC: objednat onkologii a návazná vyšetření, informovat pacientku, po jejím souhlasu i dceru Petru Horkou.

V Praze dne 21. 10. 2026 · doc. MUDr. Pavel Hrubý, Ph.D., předsedající MDT · Kopie: MUDr. Tomáš Řezníček, praktický lékař, Na Návsi 3, 252 41 Dolní Břežany